

护理,对有发热的患者作血细菌培养和药敏试验,及时更换敏感抗生素。进食高蛋白、高热量、高维生素、易消化的半流质饮食,以增加患者抵抗力,促进吻合口愈合。

2.2.8 血栓和栓塞 主动脉人造血管置换术后,在重建血管吻合口,动、静脉腔内易发生血栓和栓塞。为了防止人造血管内血栓形成,遵医嘱术后最初 3 个月内给予抗凝治疗,抗凝药的应用通常在术后 6~12 h 开始。术后早期给予低分子肝素钠皮下注射,患者可进食时,则改为拜阿斯匹林或波立维口服,本组无 1 例血栓栓塞发生。

2.2.9 皮肤护理 术后患者卧床时间长,应加强皮肤护理,每班进行 Braden 评分,对患者的皮肤情况进行评估,防止压疮的发生。做好口腔及会阴护理,针对不同的危险因素实行不同的护理措施。

2.2.10 出院指导 新疆少数民族地区,由于特殊地理环境与气候变化,少数民族饮食每日以肉食为主,蔬菜水果进食少,且喜饮浓砖茶、酒等,导致肥胖、血脂增高、血压增高,易患心血管疾病。出院后要改变饮食习惯,进食清淡、易消化、低脂食物;坚持定时定量服用药物,不可擅自加药或停药;也不可以因一顿漏服下顿补服。遵医嘱调整药物用量。定期去门诊复查,定期检测凝血指标,主要关注 INR 使其维持在 2.0~3.0 的范围。告知患者服用抗凝药有出血的危险,平时要做好自我监测,在服药过程中观察有无口腔黏膜出血、鼻衄、消化道或尿道的出血,月经量的增多等现象。

3 小结

Stanford A 型主动脉夹层起病凶险,病情危急,采用主动脉夹层的细化分型以及推荐的手术术式,结合临床实际决定手术时机,周密的准备、术中良好的体外循环管理和麻醉配合及各种辅助设施的广泛应用,使 Stanford A 型主动脉夹层能够得到较好的治疗。但良好的围手术期护理是保证患者手术成功、加快术后恢复和提高患者生活质量的重要环节。

参考文献

- 1 Meszaros I, Morocz J, Szilvi J, et al. Epidemiology and clinicopathology of aortic dissection [J]. Chest, 2000, 117: 1271-1278.
- 2 Yu HY, Chen YS, Huang SC, et al. Late outcome of patients with aortic dissection: study of a national database [J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2004, 25: 683-690.
- 3 Crawford ES, Crawford JL. Disease of the aorta. 1st ed [M]. Baltimore: Williams&Williams, 1984: 168-214.
- 4 凌桂芳,周静文,林春喜,等.主动脉夹层的急救护理[J].中华实用医药杂志,2003,3(11):41.
- 5 李梅,缪东梅,邹小明. Bentall 全弓置换加象鼻手术治疗 1 例马凡综合征病人的护理[J].南方护理学报,2004,11(1):60-61.
- 6 张爱军. 急性主动脉夹层临床治疗分析[J].中国现代医生,2007,45(15):38-39.
- 7 Orihashi K, Surda T, Okada K, et al. Detection and monitoring of complications associated with femoral or axillary arterial cannulation for surgical repair of aortic dissection [J]. J Cardiothorac Vasc Anesth, 2006, 20(1):20-25.

(本文编辑:王溪婷)

老年痴呆患者睡眠障碍护理干预效果评价

谭晓雪 何玉球 梁月冰 李容 邓丽娟 招丽嫔 林春洁 翟维维

【摘要】目的 探讨护理干预对 AD 患者睡眠障碍的影响。**方法** 将 50 例患睡眠障碍 AD 患者,随机分为对照组和观察组各 25 例,两组均接受常规护理和健康教育,观察组在此基础上实施护理干预,包括对患者、照顾者、家属通过加强对疾病的认识,采用加强睡眠卫生教育,如创造良好的睡眠环境、培养良好的睡眠习惯、科学合理饮食、睡眠行为指导、调整精神状态、用药护理、安全护理等行之有效的护理干预。干预后比较两组安全意外发生率和观察组干预后潜伏睡眠、睡眠时间。**结果** 观察组安全意外发生率明显低于对照组,差异有显著性($P < 0.05$)。观察组与干预前和对照组比较潜伏睡眠缩短、睡眠时间明显延长,差异有显著性($P < 0.01$)。**结论** 充分评估患者,实施有效的护理干预措施,能积极改善 AD 患者睡眠障碍的睡眠状态,可明显恢复患者体力,改善其精神状态,避免或减少安全意外发生,有利延缓 AD 患者疾病进展,从而减轻家庭、社会负担。

【关键词】 老年痴呆; 睡眠障碍; 护理干预; 行为改变; 生存质量

中图分类号: R473.5

文献标识码: B

随着社会的老齡化,老年性痴呆(AD)的发病率日益增多,65 岁以上人群患病率约 5%,85 岁以上人群患病率约 20%^[1]。睡眠障碍是指人们难以入睡,或难以持续睡眠,或

在第二天醒来没有睡足感和重获精力的感觉,主要为患者进入睡眠的潜伏期延长,入睡过程中生理性感觉增多。AD 患者睡眠障碍十分常见,睡眠障碍可能是 AD 危险因素之一,顽固性失眠常为 AD 先兆症状^[2],研究证实,AD 相关睡眠障碍发病率可达 34%~82%^[3],可见睡眠障碍是威胁 AD 患者身心健康的重要因素,导致 AD 患者慢性病增加或加重,不仅影响 AD 患者生存质量和躯体健康,还给社会、家庭带来巨

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4351.2010.09.024

基金项目:广东省佛山市科技局立项课题(批号 200804024)

作者单位:528041 广东省佛山市第三人民医院神经内科

大负担,为寻求对 AD 患者睡眠障碍的有效护理方法,本文于 2008 年 6 月至 2009 年 5 月对 25 例 AD 患者睡眠障碍实施护理干预,效果满意,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择在我院神经内科和老年科住院的 AD 患者睡眠障碍 50 例。纳入标准:通过简易精神状态 (MMSE) 检查,符合 CCMD-3 关于老年性痴呆^[4]的诊断标准,无严重躯体疾病,将其随机分为观察组和对照组各 25 例,两组患者基线比较,差异无显著性意义 ($P>0.05$),有可比性,见表 1。

表 1 两组 AD 患者基线资料比较 ($\bar{x} \pm s$)

组别	例数		平均年龄 (岁)	受教育年限 (年)	学历			
	男	女			文盲	小学	初中	高中以上
观察组	18	7	73 $\pm$ 7	5.3 $\pm$ 3.1	3	5	5	12
对照组	16	9	78 $\pm$ 5	5.9 $\pm$ 2.7	2	6	7	10

1.2 方法

干预方法 对照组进行常规护理,并解答 AD 睡眠障碍患者和照顾者提出的相关疑问。观察组除常规护理外对其做充分评估,视个体化建立相应护理干预计划,采用家属、照顾者一同参与的护理模式给予全面护理干预。

1.3 评价指标

经护理干预后比较两组 AD 睡眠障碍患者安全意外和两组 AD 患者睡眠障碍干预前后睡眠潜伏期与睡眠时间情况作为评估 AD 患者生存质量。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 10.0 软件进行 χ^2 检验。

2 结果

2.1 两组 AD 睡眠障碍患者干预前后睡眠潜伏期和睡眠时间比较

见表 2。

表 2 两组 AD 睡眠障碍患者干预前后睡眠潜伏期和睡眠时间比较 ($\bar{x} \pm s$, min)

组别	例数	干预前		干预后	
		潜伏睡眠	睡眠时间	潜伏睡眠	睡眠时间
对照组	25	45.29 $\pm$ 5.42	238.6 $\pm$ 60.31	26.09 $\pm$ 8.21	289.30 $\pm$ 49.6
观察组	25	40.23 $\pm$ 7.03	180.24 $\pm$ 54.07	32.46 $\pm$ 8.04	225.7 $\pm$ 59.3
χ^2 值		2.850	3.603	2.772	4.113
P 值		0.006	0.001	0.008	0.000

2.2 两组 AD 睡眠障碍患者干预后安全意外情况比较

见表 3。

表 3 两组 AD 睡眠障碍患者干预后安全意外情况比较 (例)

组别	例数	自伤(杀)	跌倒	走失	骨折	激越	嗜食
对照组	25	8	11	9	9	10	8
观察组	25	1	2	2	1	2	1
χ^2 值		4.878	8.420	5.711	6.125	7.018	4.878
P 值		0.027	0.004	0.017	0.013	0.008	0.027

3 护理干预措施

AD 患者因生理和精神因素是睡眠障碍的高发人群,持续睡眠不足可导致 AD 患者常有精神疲劳,思考力及记忆力减退,警觉力、判断力下降,免疫力低下,内分泌紊乱,焦虑、烦躁,最终导致疾病的发生^[8]。据国外报道^[9],存在睡眠障碍患者自杀倾向明显高于非睡眠障碍患者。因此,AD 睡眠障碍患者护理的好坏显得尤为重要。

3.1 睡眠卫生教育

3.1.1 创造良好的睡眠环境有助于睡眠 为 AD 患者创造一个整洁、安全、舒适、光线柔和、无噪音、温湿度适宜的环境,每次治疗工作要有计划,除必要的治疗外,尽量集中在患者睡眠前,以减少觉醒次数。据报道,采用无干扰夜间医疗护理措施,平均每天可以提高患者 30 min 总睡眠时间,而且明显增加患者的持续睡眠时间^[5]。此外,夜间查房时护士应作到三轻(走路轻、推们轻、动作轻),光源不可直接射向患者,门的折页经常加润滑油,避免开关时发出声音。

3.1.2 培养良好睡眠习惯 对患有睡眠障碍 AD 患者,应充分详细评估后制订合适的作息时刻表,使其起居规律;限制白天小睡,避免午后饮用咖啡、茶、可乐等兴奋性饮料;晚睡前室内通风、枕高适宜,心境平静,放松精神避免多思多虑、过度兴奋、大声嬉笑;右侧卧位便于全身肌肉放松,呼吸通畅。

3.1.3 合理饮食 AD 患者因机体衰退和疾病所致不知饥饱、唾液分泌减少,易发生进食异常,而导致食物(或药物)在咽部噎住,造成窒息,所以除应合理制订营养全面的饮食计划,合理安排进食时间外,还要向 AD 患者、照顾者讲明哪些食物能促进或影响睡眠,在食物选择上应以高蛋白为主,如鸡、鸡蛋、瘦肉、鱼、动物肝脏、核桃、大豆等,即富含丰富蛋白质,又能较好的营养脑细胞,同时饮食应清淡、低脂。海参、鱼类等食物、枸杞粥、黑芝麻粥、枣仁猪心汤等食疗方剂,均对 AD 患者睡眠有较大帮助,还有助于其智能的改变。另外,睡前应避免大量饮水或大量进食含水较多的食物,以防夜间因入厕而干扰睡眠。

3.2 睡眠行为指导

研究显示^[6],背部按摩、音乐疗法、暗示、想象、使用摇椅等可促进身体和精神放松,提高 AD 患者的睡眠质量;鼓励 AD 患者睡前稍作活动,如散步,以增加活动量有助于肌肉放松、缓慢敲击的暗示方法可抑制感觉神经系统,减少疼痛和焦虑,减慢心率和呼吸频率,使肌肉放松,降低氧耗量,促进睡眠;睡前用热水浸泡双脚,以减少大脑血流量,降低大脑活动,按摩双脚心有舒肝催眠作用或以木梳轻柔地

长时间梳头,有助于使 AD 患者产生睡意。

3.3 调整精神状态

AD 患者多呈智能缺陷且有明显的情感障碍,有时无法用语言准确表达出心理状态,这就要求护士要善于观察,从患者微小情绪变化发现其心理的矛盾、冲突等,有针对性地解释、劝慰、鼓励工作^[7],注意语言技巧,了解他们内心的疾苦,与其建立护患信任关系,让其感觉医务人员的温暖,努力使其保持心理平衡,以延续疾病的进展。

3.4 用药护理

部分 AD 相关睡眠障碍患者在医生指导下,短期、适量地配用镇静、催眠或小剂量抗焦虑、抑郁剂,这样可能会取得更快、更好的治疗效果。对这类 AD 患者的护理要特别注意,避免由此引发成瘾等依赖行为,且在服药期间要给予 AD 患者特殊的生活护理,如告知患者在完成睡前的准备(冲凉、刷牙等)后上床就寝时服用,以防跌倒,同时护士应告知患者及照顾者镇静、催眠药物常见的不良反应。此外,在护理中护士应了解药物的效果,注意细心观察 AD 患者是否入睡,中途有无觉醒,次日觉醒时间,以及可能出现的副作用。要严格执行医嘱,不可随意增减药物,有情况应及时向医生反映,防止发生以外。指导照顾者妥善保管好药物,以免 AD 患者误服或一次大量吞服而发生意外。

3.5 安全护理

由于 AD 患者认知功能衰退,自我保护能力差,自控能力减退或丧失可发生各种安全意外。如自伤、自杀(或有自杀念头)、跌倒、走失、噎食等,而一旦发生会给患者、家庭、社会造成严重影响,所以要严加防范,必要时床头挂警示牌,患者一览表、护士站白板作明显标记,以警示工作人员、照顾者、家属协助或提醒患者,床头重点交接班,应将室内危险物品(刀、火柴等)、药物收藏看管好,加强巡视,强化指导患者重视床头呼叫铃的使用,夜尿多且服镇静安眠药物者 22:00 后不宜饮水,床头放尿壶,对定向力差的 AD 患者衣袋内放一张联系卡片,上面注明姓名、家庭地址、联系电话等,以便迷路时方便他人照应。

4 讨论

4.1 加强睡眠卫生教育,改善睡眠状态,提高 AD 患者生存质量

针对 AD 睡眠障碍患者疾病特点,课题组成员与 AD 照顾者和家属一同对 AD 睡眠障碍患者做好心理护理,为其创造良好睡眠环境,并加强睡眠卫生教育和睡眠行为指导。表 2 显示,经上述护理干预后观察组与干预前和对照组比较其睡眠潜伏期缩短,睡眠时间增加具有统计学显著性意义(均 $P < 0.01$),说明对 AD 睡眠障碍患者实施个性化护理干预效果显著,可改变 AD 患者不良睡眠习惯和不良的相关行为,从而改善 AD 患者睡眠状态,提高其睡眠质量,恢复了体力,延缓疾病的进展,生活质量也得以提升。

4.2 加强安全护理和用药护理,可降低或避免安全意外事件发生率

AD 患者由于自控能力差以及情绪激惹、抑郁或意识模糊

状态下可发生自伤(杀)、噎食、走失、跌倒(或骨折)等安全意外,而一旦发生会给患者、家庭、社会造成严重影响。课题组通过临床观察发现 AD 睡眠障碍患者安全意外中以跌倒(或骨折)、走失、激越行为易发生。本组 AD 睡眠障碍患者平均年龄 73 岁,为老年患者,人步入老年后,各种生理功能发生变化,尤其是中枢和周围神经系统的控制能力下降,骨骼肌的反射运动和肌紧张减弱,平衡功能失调,视力减退、感觉迟钝、反应差,易被行走中的障碍物绊倒;由于患者肾脏功能减退,夜尿多致夜间起床时体位骤然改变及排尿时摒气用力等易引起脑供血不足而发生晕厥、跌倒;同时本组患者多伴有基础病,其中以心脑血管疾病多见,因疾病本身及服用扩血管、利尿等药物引起直立性低血压加之睡眠障碍而服用镇静安眠药物等,皆可引起头晕、头昏、眩晕、视物不清、认知功能障碍,患者极易因站立不稳而跌倒。国外有研究报导 AD 患者易出现徘徊行为,其发生率在 63% 以上^[10],而徘徊行为的存在使 AD 患者处于摔倒、受伤和走失危险中,而老年人多骨质疏松,跌倒后又多伴骨折。激越行为是 AD 患者较常出现的最顽固的行为问题,也是 AD 照顾者感到最难应付、加重照顾者负担和精神压力的问题之一^[11],且发生率达 50% ~ 90%^[12],诱因多,行为复杂多样^[13],这些无形中给护理工作增加了难度。课题组成员针对上述特点在护理干预实施前对 AD 睡眠障碍患者予以充分评估,制订详细个性化护理计划,尤其对安全护理和用药护理,反复向患者和 AD 照顾者强调相关事宜和安全告知,并与照顾者共同严格按照计划实施护理干预措施。表 3 显示,对观察组 AD 睡眠障碍患者实施护理干预后,AD 患者安全意外发生率明显低于对照组($P < 0.05$)。说明通过正确有针对性的护理干预不但可以改善住院 AD 患者的睡眠情况和精神状态,同时也可降低其安全意外发生率,并提高 AD 患者治疗的效果,有利于 AD 患者生存质量的提升,减少家庭、社会负担。

参考文献

- 1 王维治. 神经病学 [M]. 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2006: 266 - 270.
- 2 黄流清, 邵福源. Alzheimer 病相关的睡眠障碍 [J]. 临床精神医学杂志, 2004, 14 (5): 307 - 308.
- 3 Tracten RE, Singer CM, Cummings JL, et al. The sleep disorders inventory: an instrument for studies of sleep disturbance in persons with Alzheimers disease [J]. J Slep Res, 2003, 12 (4): 331 - 337.
- 4 中华医学精神科分会. 中国精神障碍分会与诊断标准 [M]. 济南: 山东科技出版社, 2001: 32 - 34.
- 5 Rourke DJ, Klaasen KS, Sloan JA. Redesigning nighttime care for personal care residents [J]. J Gerontol Nurs, 2001, 27 (7): 30 - 37.
- 6 刘元昀, 刘惠民. 充足的夜间睡眠与健康和幸福的关系 [J]. 国外医学. 护理分册, 2001, 20 (5): 226 - 227.
- 7 Pfister A. Sleep difficulties. There is more available than reaching for the drug cabinet [J]. Krankenpfll Soins Infiem, 2001, 94 (4): 12 - 14.
- 8 杨亚娟. 脑卒中后抑郁患者睡眠障碍的临床研究 [J]. 解放军护理杂志, 2004, 21 (12): 29 - 30.
- 9 Birkhoz G, Gibson JM, Clements PT. Dying patients, thoughts of end-

- ing their lives: a pilot study of rural New Mexico [J]. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv, 2004, 42 (8): 34-44.
- 10 Hope T, Tilling KM, Gedling K, et al. The Structure of wandering in dementia [J]. Int J Geriatr Psychiatry, 1994, 9: 149-155.
- 11 周建平. 精神分裂症住院患者家属的心理健康状态及护理干预措施 [J]. 护士进修杂志, 2005, 20 (5): 474-475.
- 12 Tractenbe RE, Weine MF, Thall J. Estimating the prevalence of agitation in community-dwelling persons with Alzheimer's disease [J]. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 2002, 14 (1): 11-18.
- 13 王志稳, 肖顺贞, 刘宇, 等. 社区痴呆患者激越行为应对策略的调查分析 [J]. 中国实用护理杂志, 2004, 20 (3): 63-64.

(本文编辑: 王溪婷)

静脉镇痛泵在妇产科手术病人中的应用与护理

王海红

中图分类号: R473.71 文献标识码: B

病人自控镇痛法 (PCA) 是 70 年代提出来的, 由于近几年微电脑与现代医学的紧密结合, 使 PCA 的精确性、可靠性和安全性得到加强, 即术后病人根据自己的镇痛需要自我控制给药的时机和剂量使体内的镇痛药物浓度处于最低浓度, 从而提供满意镇痛效果。本文对 130 例妇产科腹部手术后应用镇痛泵, 效果满意, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2007 年 6 月至 2009 年 2 月我科腹部手术共 250 例, 均无手术禁忌症, 随机分为观察组 130 例, 年龄 23~65 岁, 平均 38 岁, 其中子宫全切 46 例, 子宫次切 35 例, 卵巢肿瘤切除术 30 例, 附件切除 15 例, 宫颈癌根治术 4 例。对照组 120 例, 年龄 21~71 岁, 平均 43 岁, 其中子宫全切 42 例, 子宫次切 40 例, 卵巢肿瘤切除术 28 例, 附件切除 10 例。两组病人的年龄、手术方法无统计学意义 ($P>0.05$), 具可比性。

1.2 方法

对照组术后使用传统单次肌注哌替啶的方法镇痛。观察组术后将静脉镇痛泵连于静脉通路, 通常利用术中留置的套管针连接三通, 在输液的同时将止痛药进行控制性输入, 泵内的止痛药为 0.9% 氯化钠 94 ml + 枢丹 8 mg + 高乌甲素 24 mg + 舒芬太尼 100 μ g, 在麻醉清醒后开始匀速输入直至疼痛减轻或消失, 达到患者满意为度, 一般连续应用 48~50 h, 拔除静脉泵, 整个操作过程均由麻醉师执行, 对照组病人术后根据病人疼痛及不适情况对症处理。由病房护士观察及记录两组患者术后 50 h 内情况, 包括体温、脉搏、呼吸、血压、尿量改变、是否出现恶心、呕吐、腹胀、排尿困难、肛门排气、疼痛程度、是否需要立即止痛或镇静药物输入、睡眠情况等。

1.3 观察指标

采用疼痛及镇静评分。(1) 疼痛评分标准: WHO 疼痛四级评分镇痛情况^[1], 即 I 级: 完全无痛; II 级: 轻度疼痛, 静卧时无痛或稍有疼痛, 但不需加用镇痛剂; III 级: 用药后

疼痛减轻, 能够忍受, 活动时加重; IV 级: 切口重度疼痛, 迫切要求加用镇痛剂。镇痛效果在 I~II 级者为有效。(2) 镇静评分采用 Ramsay 评分^[2,3] 1 分: 烦躁不安; 2 分: 安静合作; 3 分: 嗜睡, 能听从指令; 4 分: 外界呼吸反应敏感; 5 分: 睡眠, 对呼唤反应迟钝; 6 分: 深睡, 对呼唤无反应。2~4 分镇静满意, 5~6 分镇静过度。观察观察过程中, 如出现疼痛评分 > II 级, 镇静评分 > 4 分, 应通知医生处理。(3) 要注意观察: 生命体征、消化症状、停导尿管后排尿困难发生情况。

2 结果

(1) 观察组止痛效果评价: I 级 102 例, II 级 28 例, 止痛效果有效率为 99.2%。Ramsay 评分镇静 2~4 分 113 例, 1 分及 5~6 分 17 例, 镇静满意率为 86.2%; (2) 对照组止痛效果评价: I 级 58 例, II 级 31 例, 止痛效果有效率为 74.2%。Ramsay 评分镇静 2~4 分 69 例, 1 分及 5~6 分 51 例, 镇静满意率为 57.5%。两组止痛有效率、镇静满意率比较有显著性差异 ($P<0.05$); 所有患者较常规单次给药者发生恶心、呕吐、排尿困难等症状明显减少, 肛门排气时间 2~3 d, 较单次给药者时间无明显延长。

3 护理

3.1 做好心理护理

护士要及时了解病人术前、术后的心理状况, 做好心理护理, 减轻病人的心理负担, 给病人以适当的同情和安慰。保持环境安静舒适, 争取家属配合, 以提高病人的痛阈。护士要善于把握病人的心理特点, 给予不同的心理护理。

3.2 严密观察生命体征及病情变化

做好一般护理, 术毕回房后护士立即给病人接上多参数生命体征监护仪, 监测脉搏、呼吸、血氧饱和度、心电图情况, 每 1 小时记录 1 次, 特别注意呼吸频率和血氧饱和度变化, 严防出现呼吸抑制发生, 必要时遵医嘱给予吸氧, 检查切口敷料、引流尿管、输液管是否通畅, 注意给病人保暖, 取去枕平卧位, 如出现呕吐、头偏向一侧。

3.3 手术后病人使用 PCA 装置的注意事项

病人返回病房时, 应轻柔地抬放病人, 切勿拖、拉、拽